

VALUTAZIONI PRE-OPERATORIE SPECIALISTICHE

Consulenza Cardiologica Pre-Operatoria

- **Data:** 27/10/2025 ore 17:00
- **Medico Consulente:** Dott. Gandalf "il Grigio" (Cardiologo)
- **Quesito Clinico:** Nulla osta per artroscopia in pz (ASA 2, carotidopatia 30% sn, piastrinosi) e gestione Clopidogrel.
- **Anamnesi Cardiovascolare:**
 - **FdR presenti:** Età 70, Dislipidemia (Ipercolesterolemia, LDL 140 - controllo subottimale), Aterosclerosi documentata (carotidopatia 30% sn).
 - **FdR assenti:** Non Ipertensione, Non Diabete, Non Fumo, Non Obesità.
 - **Sintomatologia: ASINTOMATICA** per cardiopatia.
 - NEGATA angina pectoris (capacità funzionale >4 METS prima gonalgia).
 - NEGATA dispnea cardiaca (dispnea solo per sforzi intensi, da enfisema).
 - NEGATE palpitazioni, aritmie, sincope.
 - NEGATI sintomi neurologici (TIA/Ictus) - Carotidopatia asintomatica.
 - **Storia CV:** NEGATA (non pregresso IM, non scompenso, non valvulopatie, non ictus).
 - **Terapia CV:** Rosuvastatina 5mg (CONTINUARE), Clopidogrel 75mg (SOSPESO 5 gg - sospensione appropriata).
- **Esame Obiettivo Cardiovascolare:**
 - Parametri: PA 125/70 mmHg, FC 72 bpm (regolare).
 - Giugulari: Non turgore.
 - Polsi: Carotidei validi, **presente soffio sistolico carotideo sn (noto)**. Polsi periferici tutti presenti e validi.
 - Auscultazione cardiaca: **Toni ritmici, validi. NON SOFFI cardiaci patologici.** Non toni aggiunti (T3, T4). Non sfregamenti.
 - Edemi: Assenti.
- **Esami diagnostici visionati:**
 - **ECG (27/10/2025): Normale.** Ritmo sinusale 70 bpm. **Non alterazioni ischemiche (ST isoelettrico, non onde Q patologiche).** Non IVS.
 - **RX Torace (20/10/2025): Ombra cardiovascolare nei limiti.** Non cardiomegalia. Non segni di scompenso.
 - **Eco-Doppler TSA (2023):** Stenosi 30% sn, lieve, non emodinamicamente significativa, non ulcerata.
- **Valutazione Rischio Cardiovascolare Peri-Operatorio:**
 - **Revised Cardiac Risk Index (RCRI - Lee):**
 1. Chirurgia alto rischio: NO (Artroscopia = basso rischio)
 2. Storia Cardiopatia Ischemica: NO
 3. Storia Scompenso Cardiaco: NO
 4. Storia Malattia Cerebrovascolare: NO (carotidopatia asintomatica non conta)

- 5. Diabete insulinico: NO
- 6. Creatinina >2.0: NO
- **RCRI Score = 0 punti (Classe I)**
- **Interpretazione:** Rischio eventi cardiaci maggiori (IM, arresto) **MOLTO BASSO (<1%)**.
- **Capacità funzionale:** Buona (>4 METS) pre-gonalgia.
- **Chirurgia:** Basso rischio (artroscopia).
- **Conclusioni e Raccomandazioni:**
 - 1. NULLA OSTA CARDIOLOGICO all'intervento chirurgico programmato.
 - 2. RISCHIO CARDIOVASCOLARE PERI-OPERATORIO: MOLTO BASSO (RCRI Classe I, <1%).
 - 3. GESTIONE TERAPIA CARDIOVASCOLARE:**
 - **A) Statina (Rosuvastatina 5 mg): CONTINUARE** senza interruzione (effetto protettivo peri-operatorio).
 - **B) Antiaggregante (Clopidogrel 75 mg):**
 - **Sospensione pre-op: CORRETTA** (sospeso 5 giorni fa). Bilancio rischio-beneficio favorevole alla sospensione (basso rischio trombotico da sospensione vs alto rischio emorragico spinale).
 - **Ripresa post-op: RIPRENDERE in 1° GIORNATA POST-OPERATORIA (sera 28/10)**, previo consenso chirurgo (assenza di sanguinamento attivo/emartro).
 - **Interazione con EBPM:** Combinazione Clopidogrel + Enoxaparina (1° GPO) è accettabile e sicura, con monitoraggio clinico.
 - 4. PROFILASSI TEV:** (Enoxaparina 4000 UI/die x 10gg + calze) **Adeguate e condivise**.
 - 5. MONITORAGGIO:** Standard (intra-op) e clinico (post-op).
 - 6. RACCOMANDAZIONI A LUNGO TERMINE (per MMG):**
 - **Intensificazione terapia ipolipemizzante** (target LDL <100, idealmente <70). Aumentare Rosuvastatina a 10mg o aggiungere Ezetimibe.
 - Follow-up Eco-Doppler TSA annuale.
 - Ripresa attività fisica dopo recupero.

Nulla osta cardiologico confermato.

(Firma Digitale: Dott. Gandalf "il Grigio", Data: 27/10/2025 ore 17:45)

Modulo di Consenso Informato all'Intervento Chirurgico

Io sottoscritta, Arwen Undómiel, nata a Gran Burrone il 01/03/1955,

DICHIARO

di essere stata informata in modo chiaro, completo e comprensibile dal Dott. Elrond Peredhel in data 27/10/2025 ore 15:45 riguardo:

1. LA MIA PATOLOGIA:

Lesione complessa del menisco mediale del ginocchio sinistro (tipo "a manico di secchio" con frammento dislocato).

2. L'INTERVENTO CHIRURGICO PROPOSTO:

ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA DEL GINOCCHIO SINISTRO

MENISCECTOMIA SELETTIVA DEL MENISCO MEDIALE

(Descrizione: intervento mini-invasivo, in anestesia spinale, per rimuovere il frammento meniscale lesionato e instabile, preservando il tessuto sano).

3. BENEFICI ATTESI:

Riduzione/risoluzione del dolore, eliminazione dei blocchi articolari, recupero della funzionalità, miglioramento qualità di vita, prevenzione danno cartilagineo.

4. RISCHI E COMPLICANZE POSSIBILI:

Mi è stato spiegato che esistono rischi, tra cui:

- **Comuni (1-5%):** Dolore post-op, gonfiore, ecchimosi, rigidità temporanea.
- **Meno Comuni (0.1-1%):** Infezione articolare (artrite settica), Trombosi Venosa Profonda (TVP), Emartro (sanguinamento), Rigidità persistente / Algodistrofia.
- **Rare (<0.1%):** Lesioni vascolari (a. poplitea), Lesioni nervose (n. peroneo, rami safeno), Rottura LCA iatrogena, Fallimento/Persistenza dolore.
- (Complicanze anestesologiche discusse a parte).

5. ALTERNATIVE TERAPEUTICHE:

- **Proseguimento terapia conservativa:** Già tentata senza successo. Basse probabilità di successo con lesione instabile.
- **Non fare nulla:** Probabile persistenza/peggioramento sintomi, riduzione qualità vita, rischio artrosi precoce.

Mi è stato chiarito che l'intervento chirurgico rappresenta il trattamento di scelta.

6. COSA SUCCEDERÀ SE NON MI OPERO:

Probabile persistenza dolore e blocchi, peggioramento limitazione, rischio danno cartilagineo e artrosi.

7. DECORSO POST-OPERATORIO E RIABILITAZIONE:

- **Carico:** Parziale con 2 stampelle per 7 giorni, poi progressivo.
- **Medicazione:** Mantenere asciutta. Rimozione punti 12-14 giorni.
- **Ghiaccio:** 3-4 volte/die.
- **Fisioterapia:** Esercizi isometrici da subito. Fisioterapia ambulatoriale da 7-14 giorni.
- **Tempi di recupero:** Attività quotidiane 1-2 settimane, guida 2-3 settimane, attività

sportive 4-6 settimane, recupero completo 2-3 mesi.

8. CONTROLLI POST-OPERATORI:

Rimozione punti (12-14 gg), Controllo ortopedico (30 gg).

9. DOMANDE E CHIARIMENTI:

Ho avuto possibilità di fare domande (es. "Potrò tornare a camminare come prima?", "Quanto mi farà male dopo?") e ho ricevuto risposte chiare e soddisfacenti.

10. CONSENSO:

Dichiaro di aver compreso e di accettare i rischi.

PRESTO IL MIO CONSENSO LIBERO E INFORMATO

all'esecuzione dell'intervento chirurgico di:

ARTROSCOPIA DIAGNOSTICA E OPERATIVA GINOCCHIO SINISTRO - MENISCECTOMIA
SELETTIVA

Luogo e Data: Ospedale "Lothlórien", Gran Burrone, **27/10/2025**, ore 16:00

Firma della Paziente: ____Arwen Undómiel____

Firma del Medico Chirurgo: ____Dott. Elrond Peredhel____

Testimone (Coniuge): ____Aragorn Elessar____